

RH UYGUNSUZLUĞU VE Rh İZOİMMÜNİZASYONU

DÖNEM 4 — 20 SORULUK MİNİ SINAV

- 28 yaşında, G2P1, 10 haftalık gebe kadının kan grubu 0 Rh(-)'dir. İndirekt Coombs testi negatiftir. Eşinin kan grubu A Rh(+)'dir.
Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
 - Fetal anemi kabul edilerek MCA Doppler yapılması
 - Maternal alloimmünizasyon geliştiğinin kabul edilmesi
 - Gebenin duyarlanmamış RhD-negatif gebe olarak değerlendirilmesi ve uygun anti-D profilaksisinin planlanması
 - Direkt Coombs testi yapılması
 - Intrauterin transfüzyon planlanması
- RhD alloimmünizasyonuna bağlı fetal hemolizden esas olarak hangi immünglobulin sınıfı sorumludur?**
 - IgA
 - IgD
 - IgE
 - IgG
 - IgM
- RhD-negatif, indirekt Coombs testi negatif bir gebeye verilen anti-D immünglobulinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?**
 - Fetusta mevcut anemiyi tedavi etmek
 - Maternal dolaşıma geçen RhD-pozitif fetal eritrositlere karşı maternal aktif immünizasyon gelişmesini önlemek
 - Fetal eritropoezi artırmak
 - Maternal anti-D antikorlarının plasentadan geçişini engellemek
 - Fetal RhD antijen ekspresyonunu azaltmak
- Aşağıdakilerden hangisi duyarlanmamış RhD-negatif gebede anti-D profilaksisi gerektirebilecek sensitizan olaylardan biridir?**
 - Hipertansiyon
 - Demir eksikliği anemisi
 - Abdominal travma
 - Gestasyonel diyabet
 - Hiperemezis gravidarum

5. **RhD-negatif bir kadının ilk RhD-pozitif gebeliğinde ağır fetal hastalığın, sonraki duyarlanmış gebeliklere göre daha az görülmesinin temel immünolojik açıklaması hangisidir?**
- A) Primer immün yanıtta başlangıçta plasentayı geçemeyen IgM antikorlarının ön planda olması
 - B) İlk gebelikte fetal eritrositlerin RhD antijeni taşıması
 - C) İlk gebelikte plasentanın immünglobulin geçişine tamamen kapalı olması
 - D) İlk gebelikte fetomaternal kanamanın hiç oluşmaması
 - E) Maternal B lenfositlerinin ilk gebelikte çalışmaması
6. **RhD-negatif bir gebede maternal serumdaki eritrosit antikorlarının araştırılmasında hangi test kullanılır?**
- A) Direkt Coombs testi
 - B) İndirekt Coombs testi
 - C) Kleihauer-Betke testi
 - D) Apt testi
 - E) Osmotik fragilite testi
7. **Direkt antiglobulin testi (direkt Coombs) en doğru olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?**
- A) Maternal serumdaki serbest anti-D antikorlarını
 - B) Fetal RhD genotipini
 - C) Eritrosit yüzeyine bağlanmış immünglobulin ve/veya komplemanı
 - D) Fetomaternal kanama miktarını
 - E) Maternal RhD antijen yoğunluğunu
8. RhD-negatif bir gebede immün anti-D antikor bulunduğu kesin olarak gösterilmiştir. **Bu hasta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?**
- A) Anti-D immünglobulin mevcut alloimmünizasyonu geri çevirir.
 - B) Hasta fetal anemi açısından risk değerlendirmesi ve uygun fetal izlem gerektirir.
 - C) İndirekt Coombs testi negatif kabul edilir.
 - D) Fetüs mutlaka hidropiktir.
 - E) Gebelik derhal sonlandırılmalıdır.
9. RhD-negatif bir gebenin eşi RhD-pozitif ve D antijeni açısından heterozigottur. **Fetüsün RhD-pozitif olma olasılığı yaklaşık olarak kaçtır?**
- A) %0
 - B) %25
 - C) %50
 - D) %75
 - E) %100

- 10. Maternal eritrosit alloimmünizasyonunda fetüsün ilgili eritrosit antijenini taşıyıp taşımadığının belirlenmesinin temel klinik yararı aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) Fetüs ilgili antijeni taşımıyorsa o antikora bağlı fetal hemolitik hastalık gelişmez.
 - B) Maternal kan grubunu değiştirir.
 - C) Maternal antikorları dolaşımdan temizler.
 - D) Plasental yetmezliği önler.
 - E) Maternal anemiye düzeltir.
- 11. Eritrosit alloimmünizasyonuna bağlı fetal anemi riski bulunan fetüste günümüzde tercih edilen noninvaziv fetal anemi tarama yöntemi hangisidir?**
- A) Umbilikal arter S/D oranı
 - B) Duktus venozus Doppleri
 - C) Orta serebral arter tepe sistolik hızının (MCA-PSV) ölçülmesi
 - D) Amniyotik sıvı indeksinin ölçülmesi
 - E) Uterin arter pulsatilite indeksinin ölçülmesi
- 12. Alloimmünize gebede MCA-PSV'nin 1,5 MoM'nin üzerinde bulunması en çok hangi durumu düşündürür?**
- A) Fetal makrozomi
 - B) Fetal polisitemi
 - C) Orta-ağır fetal anemi açısından artmış risk
 - D) Fetal böbrek yetmezliği
 - E) Fetal hiperkalsemi
- 13. Fetal anemide MCA-PSV'nin artmasının temel fizyopatolojik nedeni hangisidir?**
- A) Kan viskozitesinin artması ve kardiyak outputun azalması
 - B) Kan viskozitesinin azalması ve kardiyak outputun artması
 - C) İntrakraniyal basıncın artması
 - D) Plasental direncin izole olarak artması
 - E) Fetal kalp hızının sürekli azalması
- 14. Rh alloimmünizasyonlu bir gebede MCA-PSV 1,6 MoM ölçülüyor. Bu hastada bir sonraki temel yaklaşım hangisidir?**
- A) Rutin gebelik izlemi
 - B) Oral demir başlanması
 - C) Fetal tıp merkezinde fetal kan örnekleme ve gerekirse intrauterin transfüzyon açısından değerlendirme
 - D) Anti-D immünglobulin dozunun artırılması
 - E) Amniyotik sıvıda AFP ölçülmesi

- 15. Şiddetli fetal aneminin ileri evresinde aşağıdakilerden hangisi görülebilir?**
- A) Hydrops fetalis
 - B) Potter sekansı
 - C) Omfalosel
 - D) Nöral tüp defekti
 - E) Holoprozensefali
- 16. Alloimmün hemolitik hastalığa bağlı fetal hidropsun temel mekanizması hangisidir?**
- A) Şiddetli anemi → yüksek debili kalp yetmezliği → yaygın fetal ödem
 - B) Hiperglisemi → fetal poliüri
 - C) Hiperkalsemi → miyokard depresyonu
 - D) Hipotiroidi → protein sentezinde azalma
 - E) Renal agenezi → sıvı retansiyonu
- 17. Aşağıdaki antikorlardan hangisi fetal eritrosit hemolizine ek olarak fetal eritropoezi de baskılayabilmesi nedeniyle özel öneme sahiptir?**
- A) Anti-Kell
 - B) Anti-Le^a
 - C) Anti-Le^b
 - D) Anti-P1
 - E) Anti-N
- 18. Önceki gebeliğinde ağır fetal anemi nedeniyle intrauterin transfüzyon uygulanmış alloimmünize bir gebenin yeni gebeliğinde en doğru yaklaşım hangisidir?**
- A) Önceki gebelik öyküsü önemli değildir; yalnızca mevcut titreye bakılır.
 - B) Önceki ağır etkilenmiş gebelik öyküsü nedeniyle yeni gebelik yüksek riskli kabul edilir.
 - C) Anti-D profilaksisi fetal riski ortadan kaldırır.
 - D) Fetal takip yalnızca üçüncü trimesterde yapılmalıdır.
 - E) Direkt Coombs testi negatifse fetal risk yoktur.
- 19. Duyarlanmamış RhD-negatif bir anne RhD-pozitif bir bebek doğurmuştur. Bu anne için en uygun yaklaşım hangisidir?**
- A) Postpartum profilaksiye gerek yoktur.
 - B) Anneye uygun postpartum anti-D immünglobulin uygulanmalıdır.
 - C) Yalnızca bebeğe anti-D immünglobulin uygulanmalıdır.
 - D) Anneye kortikosteroid başlanmalıdır.
 - E) Bir sonraki gebeliğe kadar işlem yapılmaz.

20. Klinik olarak anlamlı maternal eritrosit alloantikorları bulunan bir gebelikten doğan yenidoğanın değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en uygun kombinasyondur?

- A)** Direkt antiglobulin testi + hemoglobin + bilirubin
- B)** Maternal MCA Doppler + AFP
- C)** Kleihauer-Betke testi + HbA1c
- D)** Fetal fibronektin + NST
- E)** Tek başına umbilikal arter pH'sı

CEVAP ANAHTARI

1 C	2 D	3 B	4 C	5 A	6 B	7 C	8 B	9 C	10 A
11 C	12 C	13 B	14 C	15 A	16 A	17 A	18 B	19 B	20 A